Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Stellungnahme zur

„Stationären oder ambulanten Operation“ bei Hämorrhoiden

Die Behandlung des Hämorrhoidalleidens erfolgt stadienadaptiert. Beim Stadium 3 und 4 ist meist die Indikation zur Operation gegeben. Für die operative Behandlung des Hämorrhoidalleidens stehen verschiedene operative Verfahren zur Verfügung. Die Verfahrenswahl hängt vom Befund und von der individuellen Situation des Patienten ab. Dabei gibt es kein alleiniges Standardverfahren, das für alle Patienten in gleicher Weise geeignet ist.

Postoperativ muss bei allen proktologischen Eingriffen eine erhöhte Schmerzhaftigkeit und stärkere Nachblutungsgefahr berücksichtigt werden. Dies beruht auf der besonderen sensiblen Innervation des Anoderms und der starken Durchblutung des Corpus cavernosum recti, so dass die Blutung gelegentlich ein bedrohliches Ausmaß annehmen kann. Außerdem sind postoperative Blasen- und Darmentleerungsstörungen zu berücksichtigen. Diese besonderen Umstände machen in der Proktologie ein individuelles postoperatives Nachsorgeregime erforderlich. Ebenso müssen verfahrensabhängige Muster und Häufigkeit der Komplikationen der unterschiedlichen Operationen in die präoperativen Planungen mit einbezogen werden.

Entsprechend dem Befund ist entweder ein offenes (Milligan-Morgan) oder ein geschlossenes Exzisionsverfahren (Ferguson, Parks, Fansler-Arnold, Longo) zu wählen. Nicht selten kommen beim selben Patienten auch mehrere unterschiedliche Verfahren zur Anwendung. Intraoperativ muss das beste Verfahren – je nach Reponibilität und Gewebsbeschaffenheit – ausgewählt werden, wobei auch der präoperative Befund mit zu berücksichtigen ist.

Eine segmentäre Hämorrhoidektomie nach Milligan-Morgan kann beim geeigneten Patienten ambulant durchgeführt werden. Dies gilt i.d.R. für die Abtragung von ein bis zwei Segmenten.

Bei der Abtragung von drei (bzw. auch zwei größeren) Segmenten besteht postoperativ über ca. 24 Stunden eine erhöhte Blutungsgefahr, außerdem müssen wegen der zu erwartenden Schmerzhaftigkeit routinemäßig und in regelmäßigen Zeitabständen aber oft zusätzlich individuell dosiert Schmerzmittel gegeben werden. Da die Schmerzen individuell unterschiedlich ausgeprägt sind, muss die Therapie dem Einzelfall situationsadaptiert angepasst werden. Aus diesen Gründen sollte die Operation unter stationären Bedingungen erfolgen.

Die geschlossenen Operationsverfahren erfordern regelhaft eine längere Operationszeit. Bei zirkulärem Vorgehen nach Fansler - Arnold resultiert eine Dauer von durchweg mehr als 45 Minuten. Im Einzelfall resultiert auch ein nicht zu vernachlässigender Blutverlust. Die geschlossenen Techniken bedingen im Einzelfall ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko insbesondere bei Begleiterkrankungen wie z. B. bei Diabetes oder Gefäßerkrankungen. Hier ist daher eine stationäre Versorgung erforderlich.

./2

Geschäftsstelle
Maienstraße 3 Tel.: 0761/70438-113
79102 Freiburg Fax: 0761/70438-114

Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Die Stapler-Hämorrhoidopexie (Operation nach Longo) ermöglicht eine geschlossene Hämorrhoidenoperation ohne Tangierung des Anoderms. Aus diesem Grund kann man in den ersten 2 Wochen postoperativ eine geringere Schmerzhaftigkeit im Vergleich zu obigen Verfahren unterstellen. In mehreren Studien wird berichtet, dass bei dieser Operation aber keineswegs regelhaft von einer postoperativen Schmerzreduktion bzw. Schmerzfreiheit für die ersten 24 - 48 Stunden ausgegangen werden kann. Die mögliche Schmerzbelastung ist zudem präoperativ nicht abschätzbar. In einzelnen Fällen kann es methodenbedingt zu schweren Komplikationen wie z.B. Perforation kommen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern. Daher ist für dieses Verfahren in der Regel eine stationäre Versorgung zu empfehlen.

Freiburg, Juli 2014

Dr. B. Strittmatter
Vorsitzender BCD

Prof. Dr. A. Herold
Generalsekretär DGK

Geschäftsstelle
Maienstraße 3 Tel.: 0761/70438-113
79102 Freiburg Fax: 0761/70438-114